

ONGEVALLENVERZEKERING · FICTIEF VOORBEELD

Orthopedische expertise ongevallenverzekering

Vraagstelling van de verzekeraar · blijvende invaliditeit

ZAAKNUMMER

2025-KME-01317

BETROKKENE

PERS00N - 1

SPECIALISME

Orthopedisch

ONDERZOEK

T+24m

KERNBEVINDINGEN

De conclusies van de arts, vooraf samengevat

DIAGNOSE

Lichte bewegingsbeperking en
belastingspijn van de rechter knie na een
tibiaplateaufractuur

RELATIE MET HET ONGEVAL

Medisch aannemelijk

Geen aanwijzingen voor
een andere oorzaak

EINDSITUATIE

Bereikt

Per T+24m

VOORAFBESTAAND

Geen

Geen knieklachten of
afwijkingen bekend

BLIJVENDE INVALIDITEIT

19%

Functieverlies rechterbeen,
AMA Guides 6e druk

DOSSIER

8 van 9 stukken

1 hiaat, niet bepalend

AANGELEVERDE STUKKEN

8 van 9 stukken aanwezig



SEH-verslag met CT



Operatieverslag



Ontslagbrief



Poliklinische brieven
orthopedie



Fysiotherapie intake
en tussenrapportage



Röntgenverslag
controle



Huisartsjournaal



AAOS-vragenlijst



Fysiotherapie
eindverslag

ONTBREEKT



Gegevens verzekeraar en betrokkene

[DOSSIERORDENING](#)

Verzekeraar

OPDRACHTGEVER

Betrokkene

PERSOON-1

Geboortedatum

GEBORTE DATUM

Beroep

Monteur installatietechniek

Ongeval

T±0: val van een trap tijdens werkzaamheden

Datum onderzoek

T+24m

Kader van dit rapport

[DOSSIERORDENING](#)

Soort expertise

Ongevallenverzekering: een uitkering op grond van de eigen polis; geen aansprakelijkheid

Kernvraag

Hoeveel blijvend functieverlies is er, gemeten volgens de maatstaf van de polis?

Doel van de uitkomst

Basis voor een vaste uitkering: percentage maal verzekerd bedrag

Partijen

Verzekerde en de eigen verzekeraar; schuld speelt geen rol

Vraagstelling

Van de verzekeraar, gebaseerd op de polis

Invaliditeitspercentage

De hoofdvraag

Richtlijn rapportage

NVMSR 2024

Polis en opdracht kader

[DOSSIERORDENING](#)

Soort verzekering

Collectieve ongevallenverzekering via de werkgever; geen letselschadezaak

Polisnummer

POLISNUMMER

Polisvoorwaarden

POLISVERSIE, artikel 7 (blijvende invaliditeit)

Begrip ongeval

Zoals omschreven in artikel 1 van de polis

Dekking als uitgangspunt

Ja; de verzekeraar heeft het voorval als gedekt ongeval aanvaard (opdrachtbrief)

Invaliditeitsmaatstaf

AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6e druk, uitgedrukt als percentage functieverlies van het betrokken lichaamsdeel

Maximum voor dit lichaamsdeel

70% voor volledig functieverlies van een been, volgens de polis

Peildatum en termijn

Vaststelling blijvende invaliditeit volgens de polis uiterlijk twee jaar na het ongeval

Voorafbestaande invaliditeit

Volgens de polis in mindering te brengen

Maatstaf

De specialist past uitsluitend de door de verzekeraar aangewezen medische

maatstaf toe. De uitleg en toepassing van de polisvoorwaarden blijft voorbehouden aan de verzekeraar. Bij verschil tussen dit rapport en de polis prevaleert de polis.

Rol van de deskundige De deskundige beoordeelt uitsluitend de medische gevolgen en eventuele functionele invaliditeit. De uitleg van polisvoorwaarden en de beslissing over dekking zijn aan de verzekeraar.

Vragen van de verzekeraar

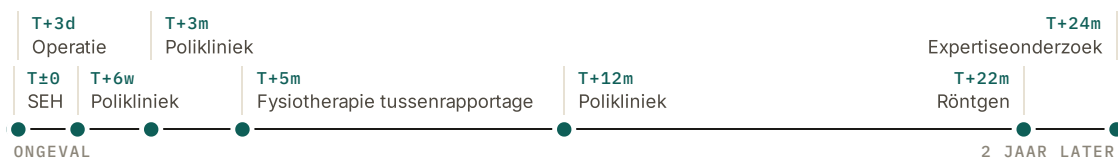
DOSSIERORDENING

Zoals gesteld in de opdrachtbrief.

- 1 Wat is de aard van het letsel en de huidige diagnose?
- 2 Zijn de huidige afwijkingen medisch het gevolg van het ongeval?
- 3 Bestonden er vóór het ongeval klachten, afwijkingen of functieverlies aan het betrokken lichaamsdeel?
- 4 Is er sprake van een medische eindsituatie? Zo nee, wanneer wordt die verwacht?
- 5 Wat is de blijvende invaliditeit volgens de maatstaf in de polis, en welk deel daarvan bestond al vóór het ongeval?
- 6 Heeft u overige opmerkingen?

Samenvatting medische informatie

DOSSIERORDENING



- T±0 ○ SEH: laterale tibiaplateaufractuur rechts, split-depressie; CT: impressie 6 mm (bron 1, p. 1–2)
- T+3d ○ Operatie: open repositie, botplastiek en plaatosteosynthese (bron 2, p. 1)
- T+6w ○ Polikliniek: goede stand, start gedeeltelijk belasten en fysiotherapie (bron 4, p. 1)
- T+3m ○ Polikliniek: consolidatie, volledig belasten (bron 4, p. 2)
- T+5m ○ Fysiotherapie tussenrapportage: flexie 110°, loopt zonder hulpmiddel (bron 5, p. 3)
- T+12m ○ Polikliniek: restklachten bij lang lopen, geen verdere behandeling (bron 4, p. 4)
- T+22m ○ Röntgen: geconsolideerd, restcongruentie 2 mm, gewrichtsspleet behouden (bron 6, p. 1)
- T+24m ○ Expertiseonderzoek

Hiaten in het dossier

DOSSIERORDENING

Fysiotherapie eindverslag

BELANGRIJK

Intake en tussenrapportage aanwezig (bron 5), maar geen afsluitend verslag.

VERWACHT T+8m · ACTIE Opgevraagd bij **ORGANISATIE-2**; niet ontvangen. Niet bepalend: het verdere beloop staat in de poliklinische brieven (bron 4).



ONDERDEEL

Beantwoording

1 Aard van het letsel en diagnose

ARTS

Anamnese, medische gegevens, onderzoek en diagnose.

Anamnese

Betrokkene vertelt dat hij van een trap viel en met gestrekt rechterbeen neerkwam. Hij werd geopereerd en liep enkele maanden met krukken. Nu heeft hij pijn aan de buitenzijde van de rechter knie na ongeveer een uur lopen en bij traplopen met gewicht. Hurken en knielen lukken slecht. Hij werkt weer volledig, maar vermijdt werk in geknielde houding. Geen pijnstillers; de plaat zit er nog.

Medische gegevens

Laterale tibiaplateaufractuur rechts, behandeld met open repositie en plaatosteosynthese op T+3d. Volledig belasten vanaf T+3m, fysiotherapie tot ongeveer T+8m. De röntgenfoto op T+22m toont een geconsolideerde fractuur met een restincongruentie van het gewrichtsvlak van 2 mm; de gewrichtsspleet is behouden.

UIT HET DOSSIER

Bronnen 1, 2, 4 en 6.

Onderzoek

Loopt zonder hulpmiddel, zonder duidelijk manken. Rustig litteken van 14 cm aan de buitenzijde van de rechter knie. Geen hydrops. Lichte drukpijn over de laterale gewrichtsspleet, zonder zwelling of crepitaties. Stabiel bij Lachman en bij varus- en valgusstress. Klinisch geen asafwijking. Meetwaarden in de tabel.

Meetprotocol

Actieve bewegingsuitslag in rugligging, gemeten met een goniometer volgens de neutraalnulmethode, drie keer per richting; vermeld is de hoogste waarde. Passief geen verdere uitslag. Omtrek met meetlint op vaste afstand van de bovenrand van de patella. Beide zijden in dezelfde volgorde gemeten. De metingen waren reproduceerbaar: per richting minder dan 5° verschil.

Diagnose

Lichte flexiebeperking en belastingspijn van de rechter knie bij een geconsolideerde laterale tibiaplateaufractuur met een restincongruentie van het gewrichtsvlak van 2 mm.

METING	RECHTS (AANGEDAAN)	LINKS (CONTRALATERALE VERGELIJKING)	ALGEMENE REFERENTIE*	KLINISCHE DUIDING	GRADE MODIFIER (AMA 6E DRUK)
Extensie-flexie	0-0-120	0-0-140	0-0-135	lichte flexiebeperking	1 (licht)
Omtrek bovenbeen, 10 cm boven patella	49,5 cm	51,0 cm	—	1,5 cm atrofie	1 (1,0–1,9 cm)
Omtrek knie, midden patella	40,0 cm	39,5 cm	—	geen hydrops	—
Stabiliteit	stabiel	stabiel	—	geen instabiliteit	0
Stand (klinisch)	neutraal	neutraal	—	geen asafwijking	0

* Algemene referentiewaarde uitsluitend ter klinische oriëntatie; zij vormt geen zelfstandige classificatie. De linkerzijde is een contralaterale vergelijking, geen referentie. Grade modifiers volgens tabel 16-7 van de AMA Guides, 6e druk.

2 Relatie met het ongeval

ARTS

Is de huidige afwijking medisch het gevolg van het ongeval?

De bewegingsbeperking en de belastingspijn zijn medisch aannemelijk gerelateerd aan de tibiaplateaufractuur en de behandeling daarvan.

DE ONDERZOEKEND ARTS

Conclusie

Op basis van het letselmechanisme, het gedocumenteerde beloop en het huidige onderzoek acht ik de bewegingsbeperking en de belastingspijn medisch aannemelijk gerelateerd aan de tibiaplateaufractuur en de behandeling daarvan.

Basis

De fractuur is op de ongevalsdag met CT vastgesteld. De klachten zijn sindsdien consistent beschreven en passen bij de restincongruentie van het laterale gewrichtsvlak. Voor een oorzaak buiten het ongeval zijn geen aanwijzingen.

UIT HET DOSSIER

Bronnen 1, 4 en 6.

Onzekerheid

Door de restincongruentie bestaat op lange termijn een verhoogd risico op artrose van het laterale compartiment. Dat is een risico, geen huidige afwijking, en telt niet mee in de huidige beoordeling.

Buiten mijn vakgebied

Niet van toepassing.

3 Toestand vóór het ongeval

ARTS

Klachten, objectieve afwijkingen en functieverlies vóór het ongeval.

Klachten

In de huisartsinformatie over vijf jaar voor het ongeval zijn geen knieklachten gedocumenteerd.

UIT HET DOSSIER

Bron 7, p. 1-2.

Objectieve afwijkingen en functieverlies

Op de CT van de ongevalsdag zijn geen aanwijzingen voor bestaande artrose. De linker knie is bij onderzoek normaal.

UIT HET DOSSIER

Bron 1, p. 2.

Conclusie

Er zijn geen aanwijzingen voor voorafbestaande invaliditeit van het rechterbeen.

4 Medische eindsituatie

● ARTS

Is de eindsituatie bereikt, en zo nee, wanneer?

Oordeel

Gelet op de tijd sinds het ongeval, de behandeling, het huidige klinisch onderzoek en de beschikbare controle-informatie acht ik de orthopedische toestand stationair. De medische eindsituatie wordt vastgesteld per T+24m.

Basis

De fractuur is geconsolideerd. Sinds de polikliniek op T+12m zijn klachten en bevindingen gelijk gebleven, en er is geen verdere behandeling gepland.

UIT HET DOSSIER

Bron 4, p. 4; bron 6, p. 1.

Onzekerheid

Het verwijderen van de plaat, als dat later gebeurt, verandert het functieverlies naar verwachting niet wezenlijk.

5 Blijvende invaliditeit

● ARTS

Volgens de maatstaf in de polis, met aftrek van voorafbestaande invaliditeit.

Oordeel

19% functieverlies van het rechterbeen volgens de AMA Guides, 6e druk. Er is geen voorafbestaande invaliditeit om in mindering te brengen. De berekening staat per stap in de rekenbijlage.

Toepassing van de polis

De omzetting naar een uitkeringspercentage volgens de polis is aan de verzekeraar.

6 Overige opmerkingen

● ARTS

Opmerkingen

Geen.



Procedure en rolverdeling

[DOSSIERORDENING](#)

Opdracht

Opdrachtbrief **OPDRACHTGEVER**
met vragen van de
verzekeraar

Machtiging

Getekende machtiging van
betrokkene

Dossierordening

Kinetic: ordening, tijdlijn,
bronverwijzingen en hiaten,
zonder medische duiding

Onderzoek

Anamnese en lichamelijk
onderzoek door **ARTS**,
basisarts, onder supervisie
van de specialistVerificatie en
eindverantwoordelijkheidDe ondertekenend specialist
heeft betrokkene zelf gezien
op T+24m, de relevante
orthopedische bevindingen
geverifieerd en draagt de
eindverantwoordelijkheid voor
diagnose, beschouwing en
conclusies

Verzekeraar

Controleert vraagstelling,
feitelijke gegevens en
volledigheid; niet de
medische inhoud

Richtlijn

NVMSR-richtlijn medisch
specialistische rapportage
2024

Inzage en blokkeringsrecht

[DOSSIERORDENING](#)

Gewezen op recht

Bij het onderzoek, mondeling
en schriftelijk

Concept toegezonden

T+24m, met termijn van twee
weken

Reactie betrokkene

Geen correcties

Blokkeringsrecht

Na inzage geen gebruik van
gemaakt

Disclosure statement

[DOSSIERORDENING](#)

Specialist	Specialisme orthopedie, BIG BIG-NR ; werkzaam in ORGANISATIE-9	Onderzoekend arts	Basisarts, BIG BIG-NR ; in dienst van Kinetic
Ervaring als deskundige	Specialist: ruim twintig jaar orthopedisch chirurg, circa 50 expertises per jaar; onderzoekend arts: drie jaar ervaring met expertiseonderzoek	Nevenfuncties	Geen nevenfuncties met een relatie tot partijen in deze zaak
Belangenconflicten	Geen; geen eerdere behandelrelatie met betrokkene en geen financieel belang bij de uitkomst	Relatie met de verzekeraar	In de afgelopen twaalf maanden zes opdrachten van deze verzekeraar



ONDERDEEL

Bijlage

B Rekenbijlage blijvende invaliditeit

● ARTS

Berekening volgens de AMA Guides, 6e druk, hoofdstuk 16 (onderste extremiteit).

Methode

Diagnosegebonden methode (DBI). De bewegingsuitslag is niet als zelfstandige methode gebruikt, omdat er een passende diagnoserij is; de bewegingsbeperking telt mee als grade modifier.

Gevoeligheid

Wordt de grade modifier voor aanvullend onderzoek niet meegeteld, dan blijft de uitkomst 19%. De netto-aanpassing is dan -2 in plaats van -3, en beide leiden tot graad A.

REKENBIJLAGE		CONTROLEERBAAR PER STAP
1	Editie en versie	AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6e druk
2	Diagnoserij (tabel 16-3, knie)	Tibiaplateafractuur met ≤ 2 mm stapvorming in het gewrichtsvlak
3	Klasse	Klasse 2: 14–25% onderste extremiteit (graad A–E: 19, 20, 22, 24, 25)
4	Standaardwaarde	Graad C = 22%
5	Grade modifier functionele historie (tabel 16-6)	1: AAOS Lower Limb-vragenlijst licht verminderd; geen hulpmiddel
6	Grade modifier lichamelijk onderzoek (tabel 16-7)	1: minimale palpatoire bevindingen, lichte bewegingsbeperking, 1,5 cm atrofie
7	Grade modifier aanvullend onderzoek (tabel 16-8)	1: gewrichtsspleet minder dan 25% versmald ten opzichte van links. De stapvorming is al gebruikt voor de klasse en telt niet opnieuw mee
8	Netto-aanpassing	$(1 - 2) + (1 - 2) + (1 - 2) = -3$; maximaal twee graden omlaag, dus graad A
9	Functieverlies onderste extremiteit	19%
10	Aftrek voorafbestaande invaliditeit	Niet van toepassing (vraag 3)
11	Uitskomst volgens de maatstaf van de polis	19% functieverlies van het rechterbeen

Bronnenlijst

DOSSIERORDENING

NR.	DOCUMENT	BRON	DATUM	PAG.
1	SEH-verslag met CT rechter knie	ORGANISATIE-1	T±0	1–2
2	Operatieverslag plaatosteosynthese	ORGANISATIE-1	T+3d	1
3	Ontslagbrief	ORGANISATIE-1	T+6d	1
4	Poliklinische brieven orthopedie	ORGANISATIE-1	T+6w–T+12m	1–4
5	Fysiotherapie intake en tussenrapportage	ORGANISATIE-2	T+2m–T+5m	1–3
6	Röntgenverslag controle beide knieën	Radiologie ORGANISATIE-1	T+22m	1
7	Huisartsjournaal	ORGANISATIE-3	T–5j–T+24m	1–2
8	AAOS Lower Limb-vragenlijst	Ingevuld door betrokkene	T+24m	1–2

Ondertekening

ONDERZOEKEND ARTS

ARTS · SPECIALIST

GECONTROLEERD EN ONDERTEKEND

ARTS · basisarts, BIG BIG-NR

Orthopedisch chirurg · BIG [BIG-NR]

Dossier geordend
Kinetic, case manager
CASEMANAGER

Anamnese en lichamelijk
onderzoek
ARTS, basisarts

Concept opgesteld
ARTS, basisarts

Inhoudelijke supervisie
Orthopedisch chirurg, BIG
BIG-NR

Kernbevindingen
geverifieerd
Orthopedisch chirurg, bij
eigen onderzoek van
betrokkene op T+24m

Eindverantwoordelijk en
ondertekend
Orthopedisch chirurg, BIG
BIG-NR

Definitief. Ondertekend op T+25m, na controle van vraagstelling en feitelijke gegevens door de verzekeraar en inzage door betrokkene.